

ALERGIAS



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

URTICÁRIA

- **Uso Oral (Anti-histamínicos):**

Loratadina 10 mg ---- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido a cada 24 horas ou de até 12/12 horas em caso de maiores sintomas por até 10 dias.

Ou

Desloratadina 5 mg --- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido à noite por até 10 dias.

Ou

Hidroxizina 25 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido até de 6/6h por até 10 dias em caso de alergia.



ROTINA CLÍNICA

URTICÁRIA

- **Uso Oral (Anti-histamínicos):**

Prometazina 25 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido até de 6/6h em caso de alergia.

Ou

Cloridrato de fexofenadina 60 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h em caso de alergia.

Ou

Cloridrato de fexofenadina 60 mg +
cloridrato de pseudoefedrina 120 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12 horas em caso de alergia.



ROTINA CLÍNICA

URTICÁRIA

- **Uso Parenteral (Anti-histamínicos):**

Prometazina 50 mg injetável ---- 1 ampola

Administrar 1 ampola, via im profunda, agora.

- **Orientações gerais (Recomendações):**

Evitar contato com substâncias alergênicas.

Procurar atendimento médico em caso de piora clínica ou na vigência dos seguintes sinais de alarme, como falta de ar, tosse intensa e dores abdominais intensas.



ANAFILAXIA

- **Uso parenteral:**

1ª droga de escolha: Adrenalina (IM)

Adrenalina 1 mg/ml ---- 1 ampola

Aplicar 0,5 ml (meio mL) no músculo vasto lateral da coxa.

Detalhe: pode repetir a dose a cada 5 minutos caso não haja melhora clínica.

- **Uso parenteral (corticoide):**

Hidrocortisona 100g/frasco ---- 3 frascos

Diluir 3 frascos em 100 ml de SF 0,9% e infundir em 30 minutos.

- **Uso parenteral (anti-histamínico):**

Prometazina 50 mg injetável ---- 1 ampola

Administrar 1 ampola, via IM profunda, agora.



ANAFILAXIA

- **Uso inalatório (beta-agonista):**

Salbutamol spray 100 mcg/dose --- 1 frasco
Inalar 4 a 10 jatos de 20/20 minutos na primeira hora, totalizando 3 ciclos. Utilizar em caso de sibilos e/ou dessaturação.

- **Cuidados gerais em cenário de emergência:**

1. Decúbito com elevação dos pés (Trendelenburg) em caso de hipotensão.
2. Oxigenioterapia sob cateter nasal ou máscara a critério médico para manter a Sat. O₂ > 94%.
3. Monitorização com oximetria de pulso. Monitorização eletrocardiográfica e multiparamétrica.
4. Manter em observação por, no mínimo, 6 horas.

